

Identificazione di pazienti con bisogni di Cure Palliative

NECPAL 4.0 2021 Versione italiana



	Bisogni palliativi	Il paziente stesso, i professionisti e/o i suoi familiari ritengono che il malato abbia attualmente bisogni di cure palliative	☐	} Almeno 1 SI NECPAL positivo
	Perdita funzionale	Giudizio clinico di deterioramento funzionale prolungato, grave, progressivo e irreversibile e/o perdita > 30% dell'indice di Barthel in 6 mesi	☐	
	Perdita nutrizionale	Giudizio clinico di calo nutrizionale/ponderale prolungato, grave, progressivo e irreversibile e/o perdita di peso > 10% in 6 mesi	☐	
	Multimorbilità	≥ 2 malattie croniche concomitanti alla malattia principale	☐	
	Utilizzo di risorse	≥ 2 ricoveri urgenti in ospedale nell'ultimo anno e/o necessità di cure continuative complesse/intense	☐	
	Malattia avanzata	Criteri di gravità e/o progressione di malattia cronica oncologica, polmonare, cardiaca, epatica, renale o neurologica (vedi sotto)	☐	

Cancro	● Metastatico o avanzato a livello locoregionale ● Cancro in progressione (tumori solidi) ● Sintomi persistenti, non controllati o refrattari nonostante l'ottimizzazione del trattamento specifico
Patologie polmonari croniche	● Dispnea per minimi sforzi ● Paziente confinato a casa con gravi limitazioni ● Criteri spirometrici di ostruzione grave (VEMS < 30%) o di restrizione severa (CV < 40% / DLCO < 40%) ● Criteri emogasanalitici predisponenti per O₂ terapia domiciliare ● Necessità di terapia corticosteroidea continuativa ● Insufficienza cardiaca sintomatica associata
Patologie cardiache croniche	● Dispnea a riposo o per minimi sforzi ● Insufficienza cardiaca NYHA stadio III o IV, malattia valvolare grave non operabile o malattia coronarica avanzata non operabile ● Ecocardiografia basale: FE < 30% o HTPA grave (PAPs > 60) ● Insufficienza renale associata (FG < 30 ml/min) ● Associazione con insufficienza renale e iponatriemia persistente
Demenza	● GDS (Global Deterioration Scale) ≥ 6c (Reisberg B et al, 1992) ● Progressione del declino funzionale, nutrizionale e/o cognitivo
Fragilità	● Indice di fragilità ≥ 0,5 (Rockwood K et al, 2005) ● CGA (comprehensive geriatric assessment) suggestiva di fragilità avanzata (Stuck A et al, 2011)
Patologie neurovascolari croniche (ictus)	● In fase acuta e subacuta (< 3 mesi post-ictus): stato vegetativo o livello minimo di coscienza ● In fase cronica (> 3 mesi post-ictus): complicanze mediche ripetute (o grave demenza post-ictale)
Patologie neurologiche croniche: malattia del motoneurone, SM, SLA, Parkinson	● Declino progressivo delle funzionalità fisiche e/o cognitive ● Sintomi complessi o refrattari ● Disfagia persistente ● Aumento delle difficoltà di comunicazione ● Frequenti polmoniti <i>ab ingestis</i>, dispnea o insufficienza respiratoria
Patologie epatiche croniche	● Cirrosi avanzata: stadio Child C (determinato in assenza di complicanze o dopo trattamento ottimale), MELD-Na score > 30 o con una o più delle seguenti complicanze: ascite refrattaria, sindrome epatorenale o emorragia digestiva alta da ipertensione portale con fallimento dei trattamenti ● Epatocarcinoma stadio C o D
Patologia renale cronica	● Insufficienza renale grave (FG < 15 ml/min) in pazienti non candidabili o che rifiutino il trapianto o la dialisi ● Sospensione della dialisi o fallimento del trapianto

Stima prognostica NECPAL 4.0

Stadio I	Stadio II	Stadio III
• DS+ • 1-2 items Mediana: <i>38 mesi</i>	• DS+ • 3-4 items Mediana: <i>17.2 mesi</i>	• DS+ • 5-6 items Mediana: <i>3.6 mesi</i>

